Saúde na Última Semana — Revista Eletrônica VIA

Revista Eletrônica VIA · iniciativa-via.com

Edição de 25 de outubro de 2026

Semana de 18 a 24 de outubro de 2026

Curadoria médico-científica · saúde pública, cuidado, ciência e tecnologia

> Esta semana, a VIA acompanha quatro pontos do cuidado: chegar ao território, manter o tratamento, confiar na medida e registrar a consulta com responsabilidade.

Em 90 segundos

Fumaça na Amazônia: novas bases federais diante de uma emergência que também depende dos rios e das rotas de atendimento.

Farmácia Popular: o programa chega a 5 mil municípios; como acompanhar o tratamento depois da retirada?

Tiras de glicemia: os sinais do produto falsificado e o que fazer diante do alerta da Anvisa.

Escribas de IA: o que pacientes perceberam quando a documentação da consulta mudou.

Continue a leitura na revista no site da VIA, com as fontes vinculadas em cada pauta e o método editorial no expediente. **Edição em revisão.**

1. Saúde e clima — Entre a fumaça e o caminho até o atendimento

Na emergência descrita pelo Ministério da Saúde no Amazonas, a fumaça encontra outro obstáculo ao cuidado: a baixa dos rios. Reduzir a exposição é uma parte da resposta; fazer equipes, insumos e pacientes atravessarem um território com transporte comprometido é outra. É nesse encontro entre risco respiratório e dificuldade de acesso que as novas bases federais precisam atuar.

A base regional da **Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS)** em Manaus começou a operar em **20 de outubro**, segundo o Ministério, para apoiar a resposta às queimadas. Um painel interno passou a reunir informações sobre insumos e rotas de transporte; **43 municípios** haviam preenchido o sistema na data da comunicação. Em **22 de outubro**, Porto Velho recebeu a quinta base regional em funcionamento no país, com cobertura planejada para a Amazônia Ocidental.

No dia **23**, o Ministério publicou orientações à população exposta à fumaça e reforçou aos profissionais o registro de intoxicações no **Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)**.

Onde a resposta precisa chegar

Material particulado fino, gases irritantes, calor, insegurança da água e interrupções de transporte podem pressionar simultaneamente a vigilância, a atenção primária, a urgência e a logística de medicamentos. O peso de cada mecanismo varia conforme exposição e condições locais de acesso. Crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças cardíacas ou respiratórias são especialmente vulneráveis à fumaça.

As bases e o painel documentam mobilização e coordenação. Para acompanhar sua efetividade, os próximos indicadores relevantes são territoriais: tempo de chegada das equipes, regularidade de insumos e atendimento nos municípios mais isolados. Os 43 municípios representam adesão ao painel naquele momento; a informação disponível ainda deixa em aberto o alcance assistencial e os resultados da resposta.

Serviço para áreas com fumaça

População: acompanhar qualidade do ar e alertas oficiais; reduzir exposição e esforço ao ar livre; manter portas e janelas fechadas quando houver fumaça; e, em saídas necessárias, preferir máscara PFF2, N95 ou P100 bem ajustada. Falta de ar, dor no peito, cansaço extremo, tosse forte ou tontura exigem avaliação; emergência é pelo **SAMU 192**.

Equipes de saúde: investigar exposição recente a fumaça diante de sintomas respiratórios, cardiovasculares ou neurológicos e seguir a orientação de notificação de intoxicação exógena no Sinan, com manejo conforme gravidade e contexto clínico.

Fontes primárias e oficiais: Manaus, MS, 20/10; Porto Velho, MS, 22/10; Proteção e atendimento, MS, 23/10; Notificação, MS, 23/10 · Ler esta pauta no site.

2. Acesso a medicamentos — Depois da primeira retirada

Fora da emergência, a continuidade do acesso é testada a cada reposição de medicamentos.

O **Farmácia Popular** chegou a **5 mil municípios** em 2026, onde reside **97,1% da população brasileira**, segundo balanço do Ministério da Saúde publicado em **23 de outubro**. A pasta informou **25,3 milhões de pessoas atendidas entre janeiro e setembro**, com oferta gratuita de 41 medicamentos e insumos.

O alcance e a próxima pergunta

A expansão pode reduzir barreiras geográficas à retirada e merece ser acompanhada como política de acesso. Para quem trata uma condição crônica, o teste seguinte se repete a cada reposição: o item estará disponível, a prescrição continuará adequada e haverá acompanhamento se surgirem efeitos adversos ou dificuldades de uso?

Os números oficiais descrevem alcance municipal e pessoas atendidas no período. Continuidade da dispensação, diferenças de acesso dentro dos municípios e controle clínico exigem indicadores próprios. A população residente nesses municípios tampouco corresponde ao total de beneficiários do programa.

Na próxima consulta: conferir o que foi efetivamente retirado, como está sendo usado e quais obstáculos aparecem entre uma dispensação e outra. Usuários podem localizar estabelecimentos e consultar os itens cobertos nos canais oficiais do programa.

Fonte oficial: Balanço do Ministério da Saúde, 23/10 · Ler esta pauta no site.

3. Alerta de serviço — Confira a tira antes da glicemia

A retirada abre outra pergunta: o produto recebido é confiável?

A **Anvisa** publicou em **22 de outubro** a proibição de tiras **Accu-Chek Active** identificadas como falsificadas em dois anúncios da Amazon. O alerta se refere aos produtos e anúncios descritos, sem estender a suspeita a toda a marca.

Como identificar: os itens descritos divergiam do original, estavam sem a embalagem externa original e exibiam a frase **“ONLY FOR GOVERNMENT TENDER”**. Esses são sinais do alerta, sem constituir um teste completo de autenticidade.

O que fazer: interromper o uso do produto suspeito, preservar embalagem e comprovante e procurar os canais da Anvisa e do fabricante. Diante de sintomas ou resultado incompatível com o estado clínico, buscar avaliação e confirmação por método confiável. Uma leitura suspeita, isoladamente, não deve orientar mudança de insulina ou outro medicamento.

Nota documental: adotamos 22/10, data de publicação do alerta e das Resoluções-RE nº 4.143 e nº 4.147/2026, datadas de 20/10. O “22/11” no corpo da notícia é uma inconsistência da página.

Fontes primárias: Anvisa, 22/10; DOU, RE nº 4.143/2026; DOU, RE nº 4.147/2026 · Ler esta pauta no site.

4. IA no cuidado — Quando o paciente percebe menos interrupções

A segurança da decisão depende também da informação que fica registrada na consulta.

Menos distrações, mais tempo para perguntas e notas percebidas como mais completas: esses foram relatos de **20 pacientes** entrevistados em estudo publicado em **19 de outubro** no Journal of General Internal Medicine. Seus profissionais participavam de um ensaio pragmático de implementação de escriba de **inteligência artificial (IA) ambiente**, que transforma áudio da consulta em rascunho de registro.

O interesse do estudo está na experiência da consulta. Familiaridade tecnológica, pouca percepção do dispositivo e uma relação prévia positiva com o profissional influenciaram o conforto relatado. Essa percepção merece investigação em seus próprios termos; concordar com a gravação e compreender o destino dos dados são questões que precisam ser examinadas separadamente.

Da conversa ao prontuário

Para os serviços, a pergunta operacional é dupla: o paciente ganhou espaço para falar e o registro permaneceu fiel ao encontro? Isso exige explicar o uso antes da gravação, oferecer recusa sem prejuízo, definir retenção e acesso aos dados e manter a revisão e a responsabilidade pelo registro com o profissional.

Escopo da evidência: pesquisa qualitativa em centro acadêmico, com saturação temática declarada pelos autores. Ela explora percepções, sem medir acurácia documental, eventos adversos ou desfechos clínicos; seleção e contexto limitam a transferência dos achados. Foram declaradas participação acionária de um autor e solicitação para que outro integrasse conselho consultivo de empresa do setor, sem remuneração por esse conselho. Os relatos ajudam a orientar avaliações de implementação; segurança e efetividade precisam de investigação própria.

Fonte primária: Nguyen et al., J Gen Intern Med, 19/10/2026; PMID 42897388; DOI 10.1007/s11606-026-10931-4 · Ler esta pauta no site.

Entre anunciar, disponibilizar e cuidar há um percurso inteiro. É nele que políticas, produtos e tecnologias deixam de ser promessa e passam — ou não — a fazer diferença.

Método editorial

Expediente VIA · leitura, acompanhamento e contato

Recorte: **18 a 24/10/2026**. Comunicados oficiais, atos regulatórios e registro bibliográfico estão vinculados em cada pauta. Números mantêm a atribuição e o período informados pela fonte; a pesquisa qualitativa é tratada segundo sua pergunta de experiência.

Leitura e fontes: Revista VIA. **Edição anterior:** 04/10/2026, em PDF. **Acompanhamento:** canal VIA no WhatsApp. **Contato institucional e correções:** WhatsApp Business.

Material educativo, destinado à compreensão de fatos em saúde. Condutas individuais dependem de avaliação clínica e das orientações assistenciais vigentes.

Dr Lucas HR Almeida Editorial · Médico generalista (FMRP-USP) CRM-SP 226836 · CRM-MG 109752